Antibioprophylaxie : Chirurgie Cardiaque

Chirurgie cardiaque (valves, pontages, péricarde) ; Transplantation ; Assistance ; ECLS avec abord chirurgical

- Céfazoline 2g IVL
- 0 à 60 min avant l'incision
- Réinjection 1g /4h per-op.
- +1g pour le priming de la CEC

ECLS percutanée avec absence de bas débit circulatoire ; Contre-pulsion

- Pas d'antibioprophylaxie

Transplantation avec assistance de longue durée (LVAD) ou de courte durée (ECLS), ou contexte de réanimation préopératoire :
Avis infectiologique recommandé
(ATCD et colonisation).

En cas d'allergie aux bêtalactamines (ou si BMR type SARM) :

- Vancomycine 20 mg/kg dans 100ml sur 2h (Dialaflow 50 ml/h)
- Débuter 1h avant la descente au bloc
- Réinjection Vancomycine 10 mg/kg IVSE sur 1h toutes les 8h.

Obèses :

- Augmenter les bêtalactamines seulement si BMI > 50 kg/m2
- Vancomycine administrer 20mg/kg de poids total

Antibioprophylaxie : Chirurgie Vasculaire

Chirurgie artérielle ouverte (Aorte et périphériques) et endovasculaire

- Céfazoline 2g IVL
- 0 à 60 min avant l'incision
- Réinjection 1g /4h per-op.

En cas d'allergie aux bêtalactamines (ou si BMR type SARM) :

- Vancomycine 20 mg/kg dans 100ml sur 2h (Dialaflow 50 ml/h)
- Débuter 1h avant la descente au bloc
- Réinjection Vancomycine 10 mg/kg IVSE sur 1h toutes les 8h.

Obèses :

- Augmenter les bêtalactamines seulement si BMI > 50 kg/m2
- Vancomycine administrer 20mg/kg de poids total
- Clindamycine 1200mg si BMI 45 à 60 kg/m2
- Gentamicine 6-7 mg/kg de poids ajusté

Poids ajusté = Poids idéal + 0,4 x [Poids total – Poids idéal]

TEA carotide sans patch prévu ; Stent nu ou absence de pose de matériel sans FDR*

***FDR : passage des guides au travers de matériel prothétique déjà présent, réintervention dans les 7jours, trouble trophique veineux ou artérielle**

- Pas d'antibioprophylaxie

Amputation de Membre

- Augmentin 2g IVL
- 0 à 60 min avant l'incision
- Réinjection 1g /2h per-op

- **En cas d'allergie aux bêtalactamines :**
- Clindamycine (Dalacine*) 900mg et Gentamicine 6-7mg/kg en IVL
- 0 à 60 minutes avant l'incision
- Réinjection Clindamycine 450mg /4h per-op.
- Pas de réinjection de Gentamicine

Antibioprophylaxie : Cardiologie interventionnelle

Cardiologie structurelle (toutes les valves et clips posés en percutanée, Occluder, fermeture de CIA/FOP)

- Augmentin 2g IVL
- 0 à 60 min avant l'incision
- Réinjection 1g /2h per-op.

Exploration hémodynamique (cathétérisme cardiaque)

- Pas d'antibioprophylaxie
- Sauf si cardiopathie cyanogène : Augmentin

Enfants :

- Augmentin 50 mg/kg (maximum 2g)
  - Réinjection 25 mg/kg toutes les 2h per-op
- Vancomycine 20 mg/kg dans **50ml** sur 2h (Dialaflow **25 ml/h**)
  - Réinjection 10 mg/kg sur 1h /8h per op
  - Si poids >20kg faire comme les adultes dans 100 ml sur 2h

En cas d'allergie aux bêtalactamines (ou si BMR type SARM) :

- Vancomycine 20 mg/kg dans 100ml sur 2h (Dialaflow 50 ml/h)
- Débuter 1h avant la descente au bloc
- Réinjection Vancomycine 10 mg/kg IVSE sur 1h toutes les 8h.

Obèses :

- Augmenter les bêtalactamines seulement si BMI > 50 kg/m2
- Vancomycine administrer 20mg/kg de poids total

Antibioprophylaxie : Rythmologie

Rythmologie (implantation ou explantation de boitier ou sonde) ; Electrophysiologie AVEC présence de prothèse intra cardiaque

- Céfazoline 2g IVL
- 0 à 60 min avant l'incision
- Réinjection 1g /4h per-op.

Electrophysiologie (Exploration ou ablation de trouble de rythme) SANS présence de prothèse intra cardiaque

- Pas d'antibioprophylaxie

En cas d'allergie aux bêtalactamines (ou si BMR type SARM) :

- Vancomycine 20 mg/kg dans 100ml sur 2h (Dialaflow 50 ml/h)
- Débuter 1h avant la descente au bloc
- Réinjection Vancomycine 10 mg/kg IVSE sur 1h toutes les 8h.

Obèses :

- Augmenter les bêtalactamines seulement si BMI > 50 kg/m2
- Vancomycine administrer 20mg/kg de poids total

Antibioprophylaxie : Chirurgie Thoracique

Chirurgie parenchymateuse, des bronches et de la trachée; Trachéotomie chirurgicale

- Céfazoline 2g IVL
- 0 à 60 min avant l'incision
- Réinjection 1g /4h per-op.

En cas d'allergie aux bêtalactamines :

- Clindamycine (Dalacine*) 900mg et Gentamicine 6-7mg/kg en IVL
- 0 à 60 minutes avant l'incision
- Réinjection Clindamycine 450mg /4h per-op.
- Pas de réinjection de Gentamicine

Médiastinoscopie ; Thoracoscopie pour biopsie ; Trachéotomie percutanée

- Pas d'antibioprophylaxie

Si BPCO Gold III ou IV :

- Amoxicilline/Acide Clavulanique 2g IVL
- 0 à 60 min avant l'incision
- Réinjection 1g toutes les 2h per-op
- Poursuivre 1gx3/j post-op pendant 48h

Gold III : VEMS 30 à 50%
Gold IV : VEMS <30% ou Hypoxie <60mmHg ou Hypercapnie >50mmHg

Obèses :

- Augmenter les bêtalactamines seulement si BMI > 50 kg/m2
- Clindamycine à 1200mg si BMI 45 à 60 kg/m2
- Gentamicine 6-7 mg/kg de poids ajusté

Poids ajusté = Poids idéal + 0,4 x [Poids total – Poids idéal]

Antibioprophylaxie : Endoscopie bronchique

Mise en place de valve endobronchique pour emphysème sévère

- Augmentin 1g IVL
- À l'induction anesthésique
- Puis 1g x3/j per os pendant 48h

Echoendoscopie

Bronchoscopie pour biopsie, désobstruction, prothèse endotrachéale ou endobronchique

- Pas d'antibioprophylaxie

En cas d'allergie aux bêtalactamines :

- Pristinamycine 1g per os
- 1h avant l'induction anesthésique
- Puis 1g x2/j pendant 48h

Obèses :

- Augmenter les bêtalactamines seulement si BMI > 50 kg/m2

Antibioprophylaxie : Chirurgie Urologique

Curage lombo-aortique, Chirurgie des voies excrétrices (uretère, urètre), Sondes JJ, Adénomectomie de prostate (chir et endo)

- Céfazoline 2g IVL
- 0 à 60 min avant l'incision
- Réinjection 1g /4h per-op.

Prostatectomie Totale et Néphrectomie Totale ou partielle

- Pas d'antibioprophylaxie

En cas d'allergie aux bêtalactamines :

- Gentamicine 6-7mg/kg en IVL
- 0 à 60 minutes avant l'incision
- Pas de réinjection de Gentamicine

Obèses :

- Augmenter les bêtalactamines seulement si BMI > 50 kg/m2
- Gentamicine 6-7 mg/kg de poids ajusté

Poids ajusté = Poids idéal + 0,4 x [Poids total – Poids idéal]

Antibioprophylaxie : Endocardite infectieuse

Patients à haut risque d'endocardite infectieuse

- Antécédent d'endocardite infectieuse
- Cardiopathie congénitale (en particulier les cardiopathies cyanogène non corrigées)
- Valve prothétique (chirurgicale et percutanée), Plastie valvulaire (avec matériel)
- Assistance ventriculaire (Heartmate, Carmat…)
- Pendant les 6 premiers mois post-implantation d'un dispositif intra cardiaque ou vasculaire (fermeture CIA/CIV, occluder, greffon vasculaire, filtre cave, dispositifs de shunt intra cardiaque…)
- Greffe cardiaque (la première année)

Pour quelle intervention ?

- Procédure dentaire ou gingivale :
  - Cefazoline 1g IVL (enfant : 50mg/kg)
- Autres procédures :
  - L'antibioprophylaxie est discutable

En cas d'allergie aux bêtalactamines :

- Pour soins dentaire : Doxycycline 100mg per os
  - 30 à 60min avant l'intervention

Obèses :

- Augmenter les bêtalactamines seulement si BMI > 50 kg/m2